

췌장암 진단 첫 30일

절제 가능성 · 유전자검사 · 항암 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 08

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

췌장암은 ‘수술이 되느냐’를 정확히 판단하는 것에서 치료가 시작됩니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Pancreatic Adenocarcinoma, Version 4.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 병기와 절제 가능성

30초 요약

- 췌장암 치료는 **절제 가능성 4단계**로 나눠 생각합니다: **절제 가능 / 경계성 절제 가능 / 국소진행(절제 불가) / 전이성**.
- **병기(1~4기)**는 크기·림프절·전이를, **절제 가능성**은 수술이 가능한지를 말합니다. 둘은 다른 질문에 답합니다.
- **모든 췌관선암 환자에게 배선(유전) 유전자검사가 권고**됩니다. 진행·전이성은 종양 유전자검사(NGS)도 합니다.
- 경험 많은 **췌장 전문 센터의 다학제 판단**이 특히 중요한 암입니다.

절제 가능성	뜻	흔한 치료 순서
절제 가능	주요 동맥에 닿지 않고, 정맥에는 닿지 않거나 조금만 닿음(둘레의 절반 미만)	수술 → 보조항암 (고위험이면 수술 전 항암 논의)
경계성 절제 가능	혈관에 일부 닿음	수술 전 항암(± 방사선) → 재평가 → 수술
국소진행	주요 혈관을 많이 감쌈	항암 ± 방사선, 반응 좋으면 수술 재평가
전이성	간·복막·폐 등 전이	전신치료 + 증상 관리

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 절제 가능성 4단계 중 어디인가요?
2. 수술을 먼저 하나요, 항암을 먼저 하나요?

3. 이 병원은 체장암 다학제 진료를 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- **열(38°C 이상)·오한 + 황달(담관염) → 해열제를 먹고 기다리지 말고 먼저 연락**
- **피를 토하거나 검은 변, 어지러움·의식 혼미(수술 후·스텐트 후 출혈 포함)**
- 심한 복통이 점점 심해짐, 계속 토함
- **수술 후 38°C 이상 발열, 배액이 탁해지거나 상처에서 고름·액체가 샘 (누출·농양 가능)**
- **심한 갈증·жа은 소변·의식 저하(고혈당) 또는 식은땀·떨림(저혈당)**
- 한쪽 다리 부종, 갑작스러운 숨참·흉통(혈전 — 체장암에서 흔함)
- 항암 중 38°C 이상 발열, 하루 4~6회 이상 설사
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 발열과 황달은 담도 스텐트가 막혀 생긴 담관염일 수 있어 빠른 치료가 필요합니다.
2. 토혈·흑변은 출혈 신호입니다.
3. 반복 구토는 십이지장이 막혔을 수 있습니다.
4. 체장암은 당뇨를 새로 만들거나 악화시킬 수 있습니다.
5. 체장암은 혈전 위험이 특히 높습니다.
6. 치료 병원이 멀면 **가까운 응급실로 먼저 가고**, 응급 카드(스텐트 종류·시술일·항암 약·마지막 투여일)를 보여 주세요.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상·조직검사 결과 확인 ② 췌장 전문 센터 예약 ③ 황달이 있으면 담도 배액 계획 확인.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ CT 판독자·조직검사 결과지(아직이면 예정일)
- ☐ 췌장암 수술·항암 경험이 많은 센터 예약
- ☐ 황달(눈·피부 노랗짐, 진한 소변)이 있으면 **담도 스텐트** 계획 확인

이번 주 할 일

- ☐ 췌장 프로토콜 CT, 흉부 CT, 필요 시 MRI(작은 간 병변 확인)·PET/CT·내시경 초음파
- ☐ CA19-9 혈액검사(황달이 있으면 높게 나올 수 있어 해석 주의)
- ☐ **배선 유전자검사** 의뢰 확인(BRCA1·2, PALB2 등)
- ☐ 체중·식사량·변 상태(기름진 변) 기록
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내)

오늘 물어볼 질문

1. 절제 가능성 판단에 필요한 검사가 다 끝났나요?
2. 황달이 있다면 스텐트는 어떤 종류인가요?
3. 유전자검사는 의뢰됐나요?

4장. 검사와 조직검사

30초 요약: 조직검사에서 암세포가 보이지 않아도 **암이 없다는 뜻이 아닐 수 있습니다.** 영상과 맞지 않으면 재검사를 논의합니다. 판독지의 작은 "미확정" 결절은 곧 전이를 뜻하지 않습니다.

검사	목적
췌장 프로토콜 CT	종양과 혈관 관계(절제 가능성)
흉부 CT	폐 전이
MRI	작은 간 전이 확인
내시경 초음파 + 조직검사	진단 확정
진단 복강경	작은 복막 전이 확인(일부)
CA19-9	추적 표지자(황달이 있으면 높게 나올 수 있고, 인구의 약 5~10%인 루이스 음성 체질은 암이 있어도 잘 오르지 않음)

 **완전판에서 이어집니다** — 판독지 용어 사전

5장. 유전자검사: 배선과 종양

30초 요약

- **배선 유전자검사**(타고난 변이): 모든 췌관선암 환자에게 권고. 결과가 **치료 선택**과 **가족 상담**에 쓰입니다.
- **종양 유전자검사(NGS)**: 먼저 **KRAS 변이 여부**를 봅니다. KRAS 변이가 없으면 드문 표적 변이(NTRK·NRG1·RET·BRAF 등)를 꼼꼼히 찾습니다. MSI(dMMR)는 KRAS 결과와 관계없이 확인합니다.
- 배선 BRCA 변이가 있는 전이성 환자는 백금 항암으로 조절된 뒤 **PARP 억제제 유지요법**을 논의할 수 있습니다(국내 허가·급여 확인 필요).

 **완전판에서 이어집니다** — 유전자 결과지 읽기, 가족 유전상담 안내

유전 기록: 배선 _ · **KRAS** _ · MSI _ · *기타* _

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 치료 경로 지도

30초 요약

- **절제 가능:** 수술 → 보조항암(약 6개월 범위). CA19-9가 매우 높거나 종양·림프절이 크거나 체중감소·통증이 심하면 **수술 전 항암**을 먼저 논의합니다.
- **경계성:** 수술 전 항암(± 방사선) → 재평가 → 수술.
- **국소진행:** 항암 ± 방사선, 반응 좋으면 수술 재평가.
- **전이성:** 다제병용 항암(체력에 따라 강도 조절) + 증상 관리.

단계	대표 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
보조 항암	다제병용 항암 또는 젬시타빈 기반, 체력이 약하면 젬시타빈 단독 또는 젬시타빈 +카페시타빈. S-1은 일본 연구 근거가 있으나 국내 보조요법 허가·급여는 확인 필요
수술 전 항암	다제병용 항암(± 방사선)
전이 성 1차	다제병용 항암 / 젬시타빈 + 알부민결합 파클리탁셀 등
체력 저하	부담이 적은 항암 또는 증상 조절 중심, 회복되면 다시 논의
2차 이후	1차와 다른 계열 항암, 표적(변이 시), 임상시험

단계	대표 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
2차 이후	1차와 다른 계열 항암, 표적(변이 시), 임상시험(RAS를 겨냥한 먹는 신약이 2차 치료에서 생존을 늘린 결과가 나와 있어, 국내 도입·임상시험 여부를 물어보세요 — 최신 근거·국내 허가 확인 필요)

- 수술 전 항암 후 재평가에서 **수술 대신 항암을 이어 가거나 다른 국소치료를 검토**할 수 있습니다. 그것도 치료 계획의 일부입니다.
- 수술 전 항암을 몇 달 할 예정이면 **금속 스텐트**가 선호됩니다. 스텐트 종류와 교체 주기를 물어보세요.
- **임상시험은 첫 치료부터** 고려할 수 있는 선택지입니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 선행항암→재평가→수술→보조항암 타임라인, 항암 주기 달력

7장. 수술(휘플 수술 등)

30초 요약: 췌장 머리 쪽은 **췌십이지장절제술(휘플 수술)**, 몸통·꼬리는 **원위부 췌장절제술**을 합니다. 경험 많은 센터에서의 수술이 합병증을 줄이는 데 중요합니다.

- 국내 수술 동의서에는 위를 살리는 **유문부 보존 췌십이지장절제술(PPPD)**이라는 이름이 자주 나옵니다. 이 수술 뒤 합병증은 10명 중 4명 정도로 흔하지만, 가장 흔한 췌장액 누출은 배액관과 금식 등으로 대개 2~3주 안에 아물고, 위가 늦게 비는 증상도 보통 1~2주 안에 나아집니다.
- 수술 후 발열, 배액 색 변화(탁함), 계속 토함·더부룩함, 출혈은 바로 연락합니다.
- 몸통·꼬리 수술(원위부 췌장절제술)은 대개 비장(지라)을 함께 떼입니다. 비장이 없으면 일부 세균 감염이 심해질 수 있어 **페렴구균·수막구균·b형 헤모필루스**

인플루엔자 예방접종을 수술 전후 알맞은 때에 맞춰야 합니다. 접종 일정을 수술 전에 확인하세요.

■ **완전판에서 이어집니다** — 휘플 수술 전후 타임라인과 합병증 신호표

8장. 진행·전이성 췌장암

30초 요약: 통계는 많은 사람의 평균이지 나의 예언이 아닙니다. 예후가 궁금하면 **언제, 얼마나 듣고 싶든지** 먼저 말해도 됩니다. 치료 목표와 함께 **나에게 중요한 것**(가족 시간, 일, 통증 없는 생활)을 의료진과 나누세요.

나에게 중요한 것: _____

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것으로** 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ **완전판에서 이어집니다**

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

먹는 것: 췌장효소·체중·혈당

30초 요약: 기름진 변·설사·체중 감소는 소화효소 부족 신호일 수 있습니다. 췌장효소제를 식사·간식과 함께 먹으면 도움이 됩니다. 체중과 근육 유지가 치료를 버티는 힘입니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 췌장효소 복용법, 체중·약력 기록, 통증·진통제 오해, 보호자와 식사 갈등

추적

- 수술 후 2년까지는 보통 3~6개월마다, 그 뒤에는 6~12개월마다 CT(또는 MRI)와 CA19-9를 확인합니다. 재발이 첫 2년 안에 많아 이 시기 검사를 빠뜨리지 않는 것이 중요합니다(담당 의료진 확인).

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 절제 가능성 4단계 중 어디인가요? 2. 병기는요? 3. 수술 먼저인가요, 항암 먼저인가요? 4. 배선·종양 유전자검사 결과는요? 5. 황달·스텐트 계획은요? 6. 항암 종류와 일정은요? 7. 임상시험에 참여할 수 있나요? 8. 췌장호소·영양 상담이 필요한가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 치료 목표는 무엇인가요?

내 췌장암 한 장 요약

항목	내 기록
위치	머리 / 몸통 / 꼬리
병기	_____
절제 가능성	절제가능 / 경계성 / 국소진행 / 전이성
CA19-9	_____ (황달 □)
배선 / KRAS	_ / _
스텐트	없음 / 플라스틱 / 금속 (시술일 _____)
첫 치료	수술 / 수술 전 항암 / 항암
임상시험	문의 □
산정특례	□신청 □완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 수술이 가능한가요? ② 유전자검사 결과는? ③ 임상시험이 있나요?

완전판에서 이어집니다

- 응급 카드 양식, 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 췌장암 용어사전
- 췌장암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Pancreatic Adenocarcinoma, Version 4.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 췌장암 정보, 한국췌장외과연구회·대한췌담도학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리 · 저작권 표시 · 내용 변경 금지 · 영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부 · 국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 쓰지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 판독지 용어 사전
- 유전자 결과지 읽기, 가족 유전상담 안내
- 선행항암→재평가→수술→보조항암 타임라인, 항암 주기 달력
- 휘플 수술 전후 타임라인과 합병증 신호표
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 웨장효소 복용법, 체중·약력 기록, 통증·진통제 오해, 보호자와 식사 갈등
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 응급 카드 양식, 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)

- 책장암 용어사전
 - 책장암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>